

CAPÍTULO 6.13

Nefropatía Diabética

PERFIL EUNACOM 1.04.1.011

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Nefropatía Diabética

Definición y Clasificación

TABLA 6.13.1: FASE VS HALLAZGO		
FASE	HALLAZGO	CARACTERÍSTICAS
Nefropatía Incipiente	Microalbuminuria	Indica daño vascular temprano. Alto riesgo cardiovascular.
Nefropatía Establecida	Macroalbuminuria o ↓ Clearance de Creatinina	Daño renal instaurado progresivo.

Diagnóstico

La pesquisa se realiza midiendo la excreción de albúmina urinaria. La recolección de orina de 24h tiene muchos errores, por lo que se prefiere la medición en muestra aislada: la **Relación Albúmina/Creatinina (RAC)**.

TABLA 6.13.2: CONDICIÓN VS ORINA DE 24H		
CONDICIÓN	ORINA DE 24H	RAC (MUESTRA AISLADA)
Normal	< 30 mg/día	< 30 mg/g (o < 0,03 mg/mg)
Microalbuminuria	30 – 300 mg/día	30 – 300 mg/g (o 0,03 – 0,3 mg/mg)
Macroalbuminuria	> 300 mg/día	> 300 mg/g (o > 0,3 mg/mg)
Rango nefrótico	> 3 g/día (3000 mg)	—

Tratamiento de la Nefropatía Diabética

- **Control Glicémico** (HbA1c objetivo).
- **Control de Presión Arterial:** Estricto < 130/80 mmHg (fundamental para frenar la progresión).
- **Manejo de la proteinuria (Antiproteinúricos):**
 - - Primera línea: **IECAs** (enalapril) o **ARA-II** (losartán).
 - - Segunda línea (add-on): Bloqueadores de canales de calcio **no-dihidropiridínicos** (Diltiazem).

Diagnósticos Diferenciales Importantes en Diabéticos

El diabético tiene derecho a tener otras nefropatías. Sospechar otra causa si hay:

TABLA 6.13.3: PRESENTACIÓN VS SOSPECHA			
PRESENTACIÓN	SOSPECHA	CONDUCTA	
Síndrome Nefrótico - Patologías Específicas	Síndrome Nefrótico (proteinuria > 3 g/día)	Glomerulopatía Membranosa	Solicitar biopsia renal para estudio.

| Hematuria dismórfica / Sd. Nefrítico | Glomerulonefritis aguda | Estudio inmunológico (ANCA, C3/C4, anti-MBG) + Biopsia. |

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Hombre de 63 años con DM2 de 15 años de evolución. Control de orina muestra Relación Albúmina/Creatinina (RAC) de 180 mg/g confirmada en 2 muestras en 3 meses. VFG 75 mL/min."

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Nefropatía Diabética Incipiente (Microalbuminuria, RAC 30-300 mg/g). Manejo: control estricto de PA (< 130/80) con IECA/ARA-II, control glicémico (iSGLT2 que reducen progresión renal), estatinas y cese tabáquico.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- La nefropatía diabética es la primera causa de enfermedad renal terminal en Chile
- Tamizaje con razón albúmina/creatinina anual: desde diagnóstico en DM2, desde 5 años en DM1
- Microalbuminuria: 30-300 mg/g; macroalbuminuria: >300 mg/g
- IECA o ARA II son primera línea incluso en normotensos con microalbuminuria
- Los iSGLT-2 tienen beneficio renal adicional demostrado
- Control de PA <130/80 y HbA1c <7%
- La lesión histológica clásica es la de Kimmelstiel-Wilson
- Suspender metformina con TFG <30 mL/min

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (NEFROPATÍA DIABÉTICA)

PREGUNTA 1

Paciente de 52 años con DM2 de 8 años de evolución, PA 125/78. Examen de orina: razón albúmina/creatinina 85 mg/g, creatinina plasmática normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

- ☐ A) Control en 1 año sin intervención
- ☐ B) Iniciar enalapril aunque sea normotenso
- ☐ C) Iniciar amlodipino
- ☐ D) Solicitar biopsia renal
- ☐ E) Iniciar diálisis preventiva

PREGUNTA 2

¿Cuál es la lesión histológica clásica de la nefropatía diabética?

- ☐ A) Proliferación mesangial difusa
- ☐ B) Esclerosis nodular de Kimmelstiel-Wilson
- ☐ C) Semilunas epiteliales
- ☐ D) Depósitos lineales de IgG
- ☐ E) Fusión de podocitos

PREGUNTA 3

¿Desde cuándo se debe iniciar el tamizaje de nefropatía diabética en un paciente con DM1 diagnosticada a los 15 años?

- ☐ A) Desde el diagnóstico
- ☐ B) A los 5 años del diagnóstico
- ☐ C) A los 10 años del diagnóstico
- ☐ D) Cuando aparece hipertensión
- ☐ E) Cuando la creatinina se eleva

RESUMEN: NEFROPATÍA DIABÉTICA

La nefropatía diabética es la principal causa de enfermedad renal crónica terminal y de ingreso a diálisis en Chile y el mundo. Se produce por daño glomerular progresivo secundario a hiperglicemia crónica, hipertensión intraglomerular y factores genéticos. Afecta al 20-40% de los diabéticos y su progresión es prevenible con intervención precoz. La historia natural progresa en etapas: hiperfiltración glomerular inicial, microalbuminuria (30-300 mg/día o razón albúmina/creatinina 30-300 mg/g), macroalbuminuria (mayor a 300 mg/día), caída progresiva de la tasa de filtración glomerular y finalmente enfermedad renal terminal. El tamizaje se realiza con razón albúmina/creatinina en muestra aislada de orina, anualmente desde el diagnóstico en DM2 y desde los 5 años del diagnóstico en DM1. El tratamiento se basa en control glicémico estricto (HbA1c menor a 7%), control de presión arterial con IECA o ARA II como primera línea (reducen la presión intraglomerular y la proteinuria), restricción proteica moderada y manejo de factores de riesgo cardiovascular. Los inhibidores de SGLT-2 (empagliflozina, dapagliflozina) y la finerenona (antagonista mineralocorticoide no esteroide) han demostrado beneficio renal adicional. Se debe ajustar la dosis de hipoglicemiantes según la función renal.